Établissement

Médecin

CONDUITE À TENIR — AS · AES · ÉDUCATEURS

Erreur médicamenteuse

Mauvais patient, médicament, dose, voie ou heure · avant ou après la prise · adulte, enfant

15 IMMÉDIAT · ne répond pas, somnolence anormale, respiration lente ou bruyante, convulsion, malaise ; gonflement du visage ou de la gorge ; insuline ou antidiabétique pris par erreur et glycémie < 0,70 g/L ; médicament à risque et IDE ou médecin injoignable.

J'applique si

- Erreur découverte **avant ou après** la prise, même évitée de justesse.

Je ne fais pas

- **Faire vomir**, donner du lait, de l'eau salée ou un « antidote ».
- Donner une autre dose pour « compenser » ou « rattraper ».
- Cacher ou minimiser l'erreur, corriger la traçabilité après coup.
- Donner un « si besoin » sans validation de l'IDE.

J'agis

TOUT DE SUITE

1. **Arrêter** toute autre prise ; rester près de la personne.
2. **Garder** blister, boîte, pilulier, gobelet, ordonnance : ne rien jeter.
3. Piluliers peut-être inversés : **vérifier tous les piluliers** du tour avant de continuer.
4. **Qui** a pris **quoi**, **combien**, à **quelle heure** ?
5. Conscience, respiration, pouls, TA, SpO2 ; **glycémie** (AS/AP) si antidiabétique.
6. Prévenir l'**IDE tout de suite**, **même si tout va bien**.

APRÈS ACCORD DE L'IDE OU DU MÉDECIN

7. Doute sur la toxicité : **centre antipoison** (n° affiché), avec l'IDE ou le médecin.

ENSUITE

8. **Déclaration interne** le jour même (« Qui signale quoi, à qui ? ») ; enfant : parents selon le PAI.

À risque

Médicaments à risque

- insuline, antidiabétique
- morphinique, benzodiazépine, neuroleptique
- anticoagulant, antiépileptique

Les 5 B

- bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment

J'appelle l'IDE sans délai

- **Toute erreur**, même sans symptôme, dès qu'elle est découverte.
- Pouls < 50 ou > 120, PAS < 100, SpO2 < 90 %, glycémie < 0,70 g/L.
- Vomissements, chute, comportement inhabituel dans les heures qui suivent.
- **IDE injoignable** : médecin d'astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Conscience, respiration, comportement aux heures fixées par l'IDE ou le médecin.
- Médicament, dose, heure, personne, signes, qui a été prévenu, consignes.

À retenir : Une erreur se signale tout de suite : c'est d'abord une urgence clinique possible, ensuite un événement à analyser sans chercher de coupable. On ne fait pas vomir, on ne compense pas.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments (2011, règle des 5B) ; centres antipoison (centres-antipoison.net) ; fiche socle DOTR « Qui signale quoi, à qui ? » (10/2026) ; arrêté du 26/06/2026 (actes AS/AP/AES), art. 2 ; CASF L313-26.

Réf. DOTR-AS-ERRMED | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature